Lineamiento Técnico LT.GM.DDSS-AAIP.29052022. Versión 1
Para el Funcionamiento, la Atención Clínica y procedimientos médicos en la Especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria en la Red Integrada de Servicios de Salud

Elaborado por:	- Dr. Francisco Ortiz Vargas, Médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Presidente de Asociación Costarricense de Medicina Familiar y Comunitaria. - Dr. Nelson Ledezma Castro, Médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria - Dra. Carla Sevilla Leiva, Médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria - Dra. Melissa Mustelier Cantero, Médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria - Dr. Robert Quirós Castillo, Médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria - Dra. Verónica Solano Corella, Médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria - Dra. Mónica Espinoza Trejos, Médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria - Dr. Tomás Meoño Martin, Médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria - Dr. David Soto Sandoval, Médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria - Dra. Lisbeth Henríquez García, Médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria - Dr. José Miguel Angulo Castro, Médico Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria - Dr. Shang Chieh Wu Hsieh, Médico Especialista en Medicina Legal/Administración de Servicios de Salud (Edición)
Revisado por:	- Dr. Mario Mora Ulloa. Enlace Dirección de Desarrollo de Servicios de Salud/Gerencia Médica. Dirección de Desarrollo de Servicios de Salud - Dr. José Miguel Angulo Castro, Médico Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Jefatura del Area de Atención Integral a las Personas
Avalado por:	- Dr. Randal Alvarez Juárez, Gerente Médico. Gerencia Médica
Para:	- Médicos Especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria de la Caja Costarricense de Seguro Social

Relación con Normativa Vigente

- Plan Estratégico Institucional 2019-2022
- Gerencia Médica. Proyecto de Fortalecimiento de la Prestación de Servicios de Salud. Guías de criterios de referencia del I al II nivel de atención. 2019.
- DDSS-AAIP-0234-2020 Solicitud de lineamiento Guías de Elaboración de Criterios de Referencia
- DDSS-AAIP-0238-2020. Ampliación al oficio DDSS-AAIP-0234-2020 Solicitud de lineamiento Guías de Elaboración de Criterios de Referencia

- Ley Organiza del Colegio de médicos y Cirujanos de Costa Rica.
- PERFIL PROFESIONAL DEL MÉDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA (MEMFC), en cumplimiento de las disposiciones de la Ley N°3019 del 8 de agosto de 1962.
- Auditoría Interna AI-1806-2020 Auditoria de e carácter especial sobre la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria.
- GM-10131-2020 de fecha 06 de agosto de 2020. Suscrito por el Dr. Mario Felipe Ruiz Cubillo. Gerente Medico.

Justificación

Según el perfil del medico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, la especialidad médica de Medicina Familiar está dedicada a brindar cuidados, centrados en la persona en su contexto familiar y comunitario de forma continua, independientemente de su edad, sexo, condición socioeconómica o de salud, integrando en el proceso de atención los factores físicos, psicológicos, sociales, culturales y asistenciales que contribuyen al proceso salud-enfermedad en pro de los sistemas de salud. La Medicina Familiar y Comunitaria (MFC) es una herramienta clave para el desarrollo y la mantención de la salud de los pueblos.

Es una especialidad médica y una disciplina académica que estudia el proceso salud enfermedad de la persona, su familia y comunidad, desde una perspectiva sistémica y un abordaje de los factores físicos, psicológicos, sociales y culturales. Su práctica es caracterizada por conocimientos, habilidades y actitudes que la diferencian de las demás especialidades.

El médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria (MEMFC) permite el apoyo efectivo a otros especialistas, ya que tiene capacidad resolutiva y actúa de manera preventiva sobre diversas patologías que el médico asistente general del primer nivel de atención considera que escapa de ese nivel y al referirlas saturan los segundos y terceros niveles de atención.
Al ser una especialidad, también puede saturarse la consulta y para evitar esta situación, la Gerencia Médica, la Comisión de Distribución de Especialistas y los entes técnicos tanto de la Red de Servicios de Salud y la Dirección de Desarrollo de Servicios de Salud pone a la disposición del primer nivel de atención, los criterios de referencia para la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria.

Objetivo

Establecer líneas generales para la atención integral a las personas usuarias por parte de la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria en el primer nivel de atención.

Fundamentación del lineamiento

El eje estratégico institucional "Prestación de los servicios de salud y pensiones con oportunidad y calidad" indica que se deben implementar una serie de líneas estratégicas mediante las cuales se fortalezca la gestión clínica de los establecimientos de salud con enfoque de red, por lo cual se incentiva el diseño e implementación de normativa técnica para el mejoramiento de la atención clínica en todos los niveles de atención y en las especialidades médicas.

Aunado a ello, la meta de la Caja Costarricense de Seguro Social de universalizar los servicios de salud institucionales exige a la institución a garantizar el acceso y brindar la cobertura del 100% del país con atención con calidad y calidez.

La especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria ha sido un pilar fundamental para garantizar en cada Area de Salud el acceso a la atención especializada a las personas usuarias brindando una atención integral en salud, sobre todo en la prevención terciaria y cuaternaria, la cual no se enfoca solamente en la atención requerida por otras especialidades sino que ofrece una visión longitudinal del pasado, presente y futuro de un ser humano para abordar los actuales problemas de salud y brindar educación en salud.

Ante la creciente demanda de la atención especializada y la capacidad de resolución del primer nivel de atención han saturado los servicios de Medicina Familiar y Comunitaria de manera que se han generado listas de espera. Según el Informe de auditoría de carácter especial AI-1806-2020, los médicos de familia gestionan el 95% de las enfermedades crónicas no transmisibles lo cual deja un 5% para profundizar en confirmar las sospechas diagnósticas de las otras patologías referidas, causas sociales y ambientales alrededor de la persona usuaria.

El presente documento pretende consolidar la atención clínica y los procedimientos médicos que realizan los Médicos Especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria que más demanda presentan en los servicios de salud, de manera que pueda servir como una herramienta útil para los especialistas que recién se incorporan a los servicios de la red integrada de servicios de salud.

Contenido

La consulta de Medicina Familiar

La consulta del Médico Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria se caracteriza por tener un enfoque clínico integrador biopsicosocial con trato humanizado; lo que contrasta con los médicos clínicos con especificidades en la atención los cuales, su campo de acción es delimitado. El MEMFC brinda además de la atención clínica, un enfoque comunitario que va desde los individuos y las familias hasta comunidades completas.

Funciones del Médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria

Desde el punto de vista legal, las funciones de los MEMFC están establecidas por Ley. La Caja Costarricense de Seguro Social, por ser una institución autónoma, debe definir las funciones que pueden realizar los MEMFC a nivel institucional y en cada centro de trabajo, por principio de disponibilidad, las funciones varían según las intervenciones prioritarias detectadas dentro del análisis de situación de salud de la comunidad. El nivel de complejidad varía según el nivel de atención, así como las habilidades de los especialistas.

A continuación, se mencionan las funciones basadas en el perfil del MEMFC establecidas en el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, los cuales son:

- Brinda atención con un enfoque integral, continuo y coordinado hacia el individuo y la familia, partiendo de esta como una unidad de atención en el contexto de su comunidad.
- Utiliza la estrategia de atención primaria como elemento fundamental en la práctica en cualquiera de los tres niveles de atención en salud. La atención primaria no debe ser confundida con el primer nivel de atención y la misma debe ser brindada todas y cada una de las especialidades médicas o quirúrgicas, en cualquier nivel de atención.
- Fomenta el trabajo en equipo interdisciplinario y la gestión intersectorial de los problemas de salud de la persona y la familia.
- Facilita la gestión de la salud, con conocimientos de los procesos económicos, políticos, demográficos, socioculturales y ecológicos en su expresión local y nacional.
- Integra, en la práctica y en la investigación, diferentes disciplinas que permiten ampliar su ámbito de acción, para favorecer las resoluciones de las necesidades poblacionales.

Responsabilidades del Médico Especialista en medicina Familiar y Comunitaria

Según el artículo 3 del Perfil del MEMFC, el profesional médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria desarrollará su labor asistencial en los servicios de consulta externa, atención en emergencias, hospitalización en todas sus modalidades, atención domiciliar, centros escolares, centros de trabajo; contando siempre con los insumos necesarios que permitan una adecuada prestación de servicios a la población.

Basado en el artículo 16 del perfil de MEMFC, las funciones asistenciales son:

a. Desarrollar su labor asistencial en los servicios de consulta externa, atención en emergencias, hospitalización en todas sus modalidades, atención domiciliar, centros escolares, centros de trabajo;

contando siempre con los insumos necesarios que permitan una adecuada prestación de servicios a la población.

b. Desarrollar sus actividades a nivel público, privado o ambos, favoreciendo el abordaje integral, familiar y psicosocial, desde una perspectiva de trabajo pluridisciplinario y en equipo.

c. Promoción de la salud. Propiciar, participar, apoyar e incentivar aquellas políticas, campañas y acciones dirigidas a mantener a la población sana, formando parte activa de los procesos, coordinando con los actores sociales para que respondan a las necesidades de las poblaciones que atiende. Podrá participar en conjunto con los departamentos de epidemiología para el análisis de aquellas enfermedades de reporte obligatorio, con miras a la identificación de comportamientos epidemiológicos anormales y la aplicación de medidas preventivas concretas.

d. Prevención de la enfermedad. Favorecer, participar, apoyar e incentivar aquellas buenas prácticas para la prevención de los factores de riesgo de la salud que propicien la afectación aguda o complicaciones de las enfermedades ya existentes en las personas, tanto a nivel de la población general, como en grupos de interés y dentro de las Instituciones públicas o privadas donde se desempeñe; realizando acciones de prevención primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria.

e. Acciones curativas. Velar por que las personas, los grupos familiares y las comunidades, reciban una atención médica integral y continua, realizando una historia clínica adecuada al individuo y a la familia, con uso adecuado de exámenes de laboratorio y de gabinete, según las normas de salud reconocidas por la comunidad científica. Además, se encargará tanto del abordaje, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de sus pacientes, así como también de la derivación oportuna hacia otros niveles de atención o servicios.

f. Rehabilitación. Identificar y cuantificar todas aquellas secuelas de la patología que presente el paciente y que se deriven de la consulta, a fin de establecer e indicar las acciones correctivas de manera oportuna durante el periodo de la enfermedad y la convalecencia. Educar a la comunidad sobre los beneficios y brindar herramientas para la rehabilitación temprana de las patologías que comprometen la autonomía y funcionalidad de las personas.

g. Evaluar las enfermedades desde el punto de vista epidemiológico, conociendo la prevalencia de estas a nivel regional, nacional o internacional.

h. Generar una presunción diagnóstica basada en la integración de los síntomas y signos que permitan un tratamiento adecuado y oportuno de la persona; además, utilizando los recursos de apoyo diagnósticos o terapéuticos.

i. Identificar las condiciones y los factores físicos, psicológicos, sociales, culturales y asistenciales, capaces de alterar el equilibrio del paciente que padece una enfermedad determinada y presenta una crisis aguda.

j. Conocer y aplicar las indicaciones, sensibilidad y especificidad de las técnicas diagnósticas exploratorias y métodos, tanto invasivos como no invasivos que se utilicen en el centro de salud asignado para ejercer su práctica médica.

k. Asistir a sesiones de equipo de aquellos casos que generarán algún reto diagnóstico o controversia en el manejo, con el fin de enriquecer el intercambio de conocimiento científico.

l. Aplicar sus conocimientos sobre la organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Salud, tanto en sus componentes de atención primaria como de servicios hospitalarios de segundo y tercer nivel, así como en el ejercicio de la medicina comunitaria.

m. Conocer a fondo los procedimientos y técnicas necesarias para la atención inicial de los pacientes agudamente enfermos y del traslado correcto y oportuno de los mismos.

n. Colaborar mediante la interconsulta con otros servicios asistenciales para el mejor desarrollo de una atención integral. La misma debe realizarse en función de los conocimientos, los medios y recursos disponibles que el profesional especialista en Medicina Familiar y Comunitaria tenga ante un caso concreto, considerando siempre presente el beneficio del paciente.

o. Formar parte del equipo de investigación en programas de peritaje en el campo de la Medicina Familiar y Comunitaria, de acuerdo con las indicaciones judiciales o administrativas.

p. Abordar las complicaciones que se deriven de su acto, mientras no se traslade el caso a otra persona profesional médico especialista.

Procedimientos médicos realizados con mayor frecuencia por parte de los Médicos Especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria

Procedimientos médicos:

Los procedimientos médicos que aparecerán a continuación son los realizados con mayor frecuencia por parte de los Médicos Especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria.

Cabe aclarar que, la realización de los procedimientos mencionados así como otros que realizan los médicos especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria dependen, como en todas las especialidades médicas y quirúrgicas, de la formación recibida en el durante la realización de la residencia médica, o proceso de formación para la Especialidad de Medicina Familiar (EMFM) como en la experiencia que dentro de la práctica asistencial se vaya obteniendo, ya que el campo de acción de la Medicina Familiar dentro de los tres niveles de atención, se enfoca en muchos casos a un área específica de trabajo.

En ocasiones se atiende o se realizan programas según las necesidades del nivel donde se ubica el MEMFC, lo cual deriva en que se adquiera en muchos casos, experiencia en un número menos amplio de procedimientos.

No obstante, la capacidad de aprender, desarrollar, investigar y aplicar procedimientos mencionados en el documento u otros no mencionados, sigue intacta.

Cabe destacar, a manera de ejemplo, que procedimientos como crioterapia de lesiones benignas y premalignas de piel, así como las condilomatosis; ultrasonido en el punto de atención en sus diferentes aplicaciones como punto de diagnóstico inicial y algunas consultas con énfasis de atención ya existentes.

Algunos de los procedimientos que se realizan son: Fondo de ojo, anestesia local, oximetría de pulso, aplicación de medicamentos tópicos, electrocardiograma, infiltraciones intralesionales con corticoides, toma de agudeza visual, nebulizaciones; colocación, retiro y revisión de dispositivo intrauterino; Doppler fetal, citología cervical, inyección de sustancias terapéuticas de acción local, vaginoscopías, administración de medicamentos supervisado en pacientes con tuberculosis, toma de agudeza auditiva o logo audiometría o audiometría verbal, taponamiento nasal anterior, monitoreo ambulatorio de la presión arterial, intubación endotraqueal, procedimientos obstétricos, atención del parto de emergencias, anticoagulación en pacientes con trombosis venosa profunda de miembros inferiores o por embolismo pulmonar, aplicación de prueba cutánea de tuberculina, campimetría, lavado gástrico, aplicación de medios terapéuticos fisiátricos, atención de la labor y del parto normal, intubación endotraqueal difícil, monitoreo fetal externo no invasivo, bloqueo de nervio periférico con localizador de nervio periférico, inyección subconjuntival, anestesia y bloqueo regional, reducción de luxaciones de articulaciones varias, espirometría y curva flujo volumen, lavado vesical, tonometría, colocación y retiro de férulas, fondo de ojo en prematuros para tamizaje de retinopatía, reducción de fracturas, sedación y relajación, taponamiento nasal anterior y posterior, Doppler arterial y venoso, colocación o terapia de VAC, perfil biofísico materno, confección de férulas y adaptaciones, colocación de sello de tórax, ecocardiografía convencional.

Procedimientos médico-quirúrgicos:

Escisiones de lesiones no complicadas de la piel (tumoraciones del tejido blando, nevus, apéndices preauriculares, entre otras), reparación de laceraciones no complicadas, extracción de cuerpo extraño no complicado, electro fulguración o cauterización, cirugía de la uña, curetaje, tratamiento de quemaduras, punción o resección de quistes, toma de biopsia, cirugía en dos o más tiempos, enucleación de hemorroide trombosada, cuidados de ostomías, plastia de pabellón auricular, criocirugía o crioterapia, cirugía para cierre de defectos con colgajos de piel, resección elíptica, curaciones oftalmológicas, cirugía por rasurado, cirugía de patología de conjuntiva y párpado, hemorroidectomía, ligadura de várices superficiales, resección quirúrgica para cierre por injertos, vasectomía.

Procedimientos médicos, manejo de heridas:

Los procedimientos de manejo de úlceras y heridas se manejan en dos escenarios, en la atención domiciliar y en el centro de salud. La revisión de las lesiones no son específicas, dada la idiosincrasia de cada persona usuaria, la respuesta al manejo puede diferir. Algunas lesiones que se manejan se mencionan a continuación:
Úlcera de presión, úlcera diabética, úlcera venosa, úlcera primaria de piel, úlcera post trauma, debridación de heridas no profundas, uso y aplicación de vendas para heridas y úlceras, cierre de heridas por primera intención, úlcera arterial, dehiscencia de suturas; debridamiento excisional, lavado quirúrgico y colocación de parches en herida; ulcera por pioderma gangrenoso, debridación de herida y muñón con complicación

quirúrgica, úlcera por hemangioma.

Procedimientos médicos, tamizaje para diagnóstico:

Frotis vaginales, urocultivos, inducción de esputo diagnóstico, cultivo de cérvix, cultivo de boca y amígdala, cultivo de uretra, cultivo de ano, toma de muestras de sangre arterial y venosa, punción vesical, hemocultivos, toma de inmunofluorescencia viral.

Procedimientos médicos, aspiración, drenaje o punción:

Abscesos superficiales (vulva, mamario, perianal, facial y cavidad oral, entre otros), lavado o limpieza de oídos, artrocentesis, paracentesis, de vía aérea superior, de nasofaríngeo, de traqueotomía, rectal, traqueal, culdocentesis, toracocentesis o pleurocentesis.

Procedimientos médicos, soporte vital cardíaco:

Básico de adulto avanzado de adulto, desfibrilación y cardioversión, avanzado pediátrico, avanzado de trauma, avanzado de trauma prehospitalario.

Procedimientos médicos, toma de vía:

Venosa periférica percutánea, arterial percutánea, intraósea, umbilical, venosa periférica por venodisección, venosa central percutánea.

Procedimientos médicos, infiltración:

Locales, partes blandas, articular, tendinosas.

Procedimientos médicos, sondaje:

Nasogástrico, vesical, digestivo.

Procedimientos médicos, diálisis crónica y aguda:

Peritoneal ambulatoria continua o cíclica, peritoneal intermitente, peritoneal continua.

Procedimientos médicos, ventilación: con presión positiva continua de la vía aérea, mecánica no invasiva.
Procedimientos médicos, transfusiones, consultas con énfasis de atención ya existentes desarrollados por colegas de Medicina Familiar en algunas zonas del país como atención paliativa, clínica del sueño, clínica de atención de adolescentes y clínica de cefaleas, equipos de salud mental entre otras.

Visita domiciliar:

Se da en varios ámbitos.
Recién nacido de alto riesgo por prematuridad antes del egreso para asegurar un lugar adecuado para el menor (en conjunto con servicio social) y post egreso para seguimiento del menor en ganancia de peso, talla, condiciones de higiene. Ambiente seguro al menor, seguimiento de indicaciones médicas y en caso de niños oxigeno dependientes asociados a complicaciones del parto o prematuridad también se realiza medición de gases en compañía de terapia respiratoria.
Condiciones especiales, PCI, mielo mielomeningocele y cualquier patología que mantenga a niños y a jóvenes en cama y que les impida asistir a un centro médico.
Adulto mayor con trastorno de la marcha, síndromes de inmovilización fase III, tanto para control de sus patologías crónicas como para curación de heridas.
Pacientes en fase terminar no oncológicas referidas de Cuidados paliativos.

Hospital de día

El médico de familia es el ente profesionalmente capacitado para detectar y abordar esos casos que requieren estudios de prioridad y que a su vez se pueden manejar de forma ambulatoria. Así como para la aplicación de medicación IV como antibióticos de una dosis al día siempre que se evalúe cada caso de forma individual y prive el bienestar del usuario.

Hospital Domiciliar

Continuar la atención médica de un paciente hospitalizado desde su casa. Como en el caso de cirugías cardiovasculares en seguimiento de primera fase de rehabilitación cardiaca, cuidados de la herida, control de anticoagulación, aplicaciones de antibióticos intravenosos, curación de heridas entre otros

Variabilidad en la destreza en la realización de los procedimientos por parte del médico especialista en medicina familiar y comunitaria

Los procedimientos médicos dependen de la pericia del MEMFC y los intereses que motivaron su

autodesarrollo y capacitaciones a los que ha asistido. Los procedimientos realizados en cada centro de salud son convenidos con las autoridades del centro. Dentro de los registros de atención a nivel institucional, se visualizan procedimientos como la criocirugía, inserción y extracción de dispositivos de liberación hormonal, infiltraciones, ultrasonidos, bloqueos mioneurales que no requieren sedación, algunos procedimientos específicos de las diferentes especialidades médicas como nasofibrolaringoscopía, extracción de cuerpo extraño en nariz y oído, rinoscopia, sinuscopía, nasoscopía, control de epistaxis, colposcopías, biopsias, entre otros.

Clínicas de anticoagulados

Seguimiento de INR en pacientes anticoagulados con Warfarina y transición con Clexane previo a las cirugías.

Valoraciones preoperatorias

Determinar el riesgo quirúrgico de un usuario y dar recomendaciones previa cirugía y/o detectar casos de alto riesgo que ameriten estudios previos o valoraciones por otras especialidades

Atención integral

Consiste en la atención centrado en la persona usuaria con énfasis en la promoción, prevención, atención de la enfermedad, tratamiento y rehabilitación. La promoción y la prevención primaria y la prevención de complicaciones son consideradas las intervenciones más costo efectivas. Todo desde el enfoque de salud familiar e Integral centrado en la atención ambulatoria, con participación comunitaria, la Intersectorialidad, la calidad de la atención comparando las intervenciones disponibles Incorporación de tecnología apropiada.
Cualquier otra atención de carácter integral tal como clínica de adolescentes, Atención en salud mental, población de riesgo (indígenas), etc.

FUNCIONES ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVAS

Es importante recordar que, en el caso de la especialidad de Medicina Familiar, no se mantiene un ámbito de trabajo único, sino que, en vista de las necesidades de cada Área de Salud, cada Hospital o cada centro de trabajo operativo o administrativo, Gerencia o programa o proyecto donde exista la especialidad, se trabaja conforme al diagnóstico de problemas y las necesidades que responden a dichos problemas.
El profesional médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria realiza sus funciones en todas aquellas áreas del conocimiento médico que emplea para la promoción de la salud, para el diagnóstico, pronóstico, tratamiento y prevención de las enfermedades.
Brinda una visión biologista, económica, socioeconómica, política sanitaria y social para la gestión de los

servicios basados en el diagnostico de situación de salud de los lugares adscritos a los servicios de salud de manera que pueda enfocar las intervenciones basados en los problemas sociales, determinantes de la salud, abordaje tanto de la salud individual, familiar y comunitario.
Identifica aquellos recursos comunitarios disponibles para la atención integral de las personas en prevención, diagnóstico, atención y rehabilitación.

FUNCIONES DE INVESTIGACIÓN

La persona especialista en Medicina Familiar y Comunitaria cuenta con los conocimientos en metodología de la investigación, epidemiología y medicina basada en evidencia. Así mismo, es capaz de utilizar la técnica y el arte, mediante el diseño, ejecución y asesoría de investigaciones básicas, clínicas y sociales, para el desarrollo del conocimiento y el avance de las condiciones de salud de la población.

FUNCIONES DE DOCENCIA

Podrá participar en la formación académica universitaria de pregrado, grado y posgrado de los profesionales en Medicina, de la especialidad en Medicina Familiar y Comunitaria, así como de otras especialidades y demás Ciencias de la Salud.

Algunos elementos de referencia por parte del Primer Nivel de Atención a la Especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria

Como se menciona anteriormente, la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria no posee un ámbito de acción específico, sino que hace un diagnóstico de situación de salud y necesidades del centro de salud en el que se encuentra y genera las intervenciones que responden a dichas necesidades.
En ese entendido, cualquier sistema de referencia o contrarreferencia debe ser guiado hacia ese ámbito de aplicación de la especialidad. Por ejemplo, en algunas Áreas de Salud u Hospitales, nuestros especialistas atienden población infantil, en otros, población ginecológica de alto riesgo, en otras desarrollan programas de clínica de heridas, hospitalización, cirugía menor, clínica de cefaleas, e inclusive, programas a nivel Gerencial distintos, entre las funciones anteriormente mencionadas.

A continuación, se trata de resumir aquellas patologías que frecuentemente se pueden presentar en la consulta médica de los cuales, al agotarse la capacidad resolutiva se debe referir a un nivel de resolución de mayor complejidad al contar con un médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria

Hipertensión Arterial	Presión arterial que permanece por encima de la

	meta a pesar del uso de 3 medicamentos antihipertensivos de manera concomitante de diferentes clases. O dos antihipertensivos y un diurético en el cual la persona usuaria si haya tenido adherencia al medicamento. Paciente de difícil manejo Sospecha de HTA secundaria (Síndrome de Cushing, acromegalia, enfermedad renal/renovascular, feocromocitoma, hipercalcemia, hipertiroidismo, apnea obstructiva del sueño (AOS) y otros.) Debe incluir los siguientes estudios: EKG y Radiografía de Tórax Perfil lipídico completo Hemograma PFR- PFH Glicemia en ayunas y HbA1c si es DM Electrolitos- CPK total y MB Pruebas de función tiroidea EGO-Proteinuria
Diabetes Mellitus tipo II	Glicemias que se mantienen por encima de la meta a pesar del uso simultáneo de 2 medicamentos hipoglicemiantes Orales y/ o de uso de insulina basado en las Guías de Diabetes Mellitus avalado mediante oficio GM-MDD-7154-2020. Con HBA1c mayores a 8.5 % durante el último 6 meses a pesar de ajustes de tratamiento e inicio de tratamiento con insulina. Debe incluir los siguientes estudios: EKG y Radiografía de Tórax Perfil lipídico: colesterol total, LDL, HDL, Triglicéridos Hemograma Pruebas de función renal Glicemia en ayunas y HbA1c Electrolitos

	EGO Pruebas de función tiroidea Proteinuria
Patología Cardiovascular	Angina inestable Arritmias cardíacas Disnea de origen cardíaco o sospecha de insuficiencia cardíaca. Sospecha de soplo orgánico • Debe incluir la descripción del soplo. • Características del soplo: Sistólico o diastólico, grado del soplo irradiación (cuello o axila), foco en que se ausculta. • Signos de insuficiencia cardiaca: ritmo de galope, Crépitos, sibilancias (asma cardiaca), IY a 45 grados, hepatomegalia, ascitis, edemas periféricos. Angina estable con dolor torácico Otras patologías según el criterio del médico tratante
Patología ginecológica en Áreas de Salud que no cuentan con Médico Especialista en Ginecología	Amenorrea con periodos menstruales durante la edad reproductiva de la mujer por más de 3 meses de iniciados los síntomas. Infertilidad. (mujer con pareja estable con más de 1 año de intentar alcanzar el embarazo que tengan más de 2 años de no usar anticonceptivos y de tener relaciones sexuales constantes de al menos 1 vez a la semana), según lo establecido en el Manual de Procedimientos de la Unidad de Medicina Reproductiva de Alta Complejidad en la Red de Servicios de Salud de la CCSS UMRAC avalado por la Gerencia Médica mediante oficio GM-MDE-4067-2020. Menopausia: Ausencia de menstruación después de 12 meses continuos o ausencia de útero. Climaterio: Cambios Fisiológicos que se inician con la

	disminución de la actividad hormonal del ovario. Síndrome de ovario poliquístico: Asociación de hiperandrogenismo con anovulación crónica, sin otras enfermedades hipofisiarias o suprarrenales y que está frecuentemente asociado a resistencia a la insulina. Patología tumoral ginecológica. Las sospechas de malignidad deben ser referidos directamente al servicio de la Especialidad de Oncología para evitar atrasos en la atención de la persona usuaria en estas patologías. Sangrado uterino anormal. Sangrado uterino disfuncional u anormal de más de 6 meses de evolución y que persiste a pesar del uso de tratamientos Hormonales orales y/o presencia de dolor constante que no cede con tratamiento analgésico antiinflamatorio. Incontinencia urinaria de esfuerzo. Dolor pélvico crónico por más de 3 meses de evolución. Otras patologías según el criterio del médico tratante
Patología neurológica	Cefaleas: Ver anexo 1 Epilepsia. Debut. Pacientes referidos por las Unidades de Ictus, Centros primarios y avanzados de ictus según el Manual de Gestión MG.GM.DDSS-AAIP.250222. Versión 00 Otras patologías según el criterio del médico tratante
Patología Gastrointestinal	Diarrea Crónica Constipación crónica una vez agotada la capacidad resolutiva del primer nivel de atención. Síndrome de Intestino Irritable tratado, una vez agotada la capacidad resolutiva del primer nivel de atención.

	Pérdida de peso no intencional de más de 5% en 6 meses Presencia de H. pylori demostrada por exámenes de Laboratorio o gabinete Depósito de lípidos en Hígado por US. Enfermedad crónica del Hígado Disfagia que se presenta con ingesta de líquidos en mayor medida que sólidos Otras patologías según el criterio del médico tratante
Patología neumológica	Asma bronquial de difícil manejo Tos crónica una vez agotada la capacidad resolutiva del primer nivel Disnea crónica Enfermedad pulmonar obstructiva crónica Apnea del sueño Radiografía de tórax alterada (tanto PA como lateral)
Patología Renal	Proteinuria persistente Nefropatía diabética e hipertensiva incipiente o instaurada Insuficiencia Renal Crónica en estadios tempranos Nefropatía mesoamericana o nefropatía asociada a trabajadores de los ingenios de caña Otras patologías según el criterio del médico tratante
Patología reumatológica	Condición de 3 o más meses de evolución con afección músculo esquelética, que presente alteración funcional, articular y/o sistémicas (fiebre, ataque severo al estado general, brotes cutáneos, lesiones de mucosas, limitación de la fuerza muscula, lesiones oculares etc.) y al menos con alguna alteración en los laboratorios (ver exámenes de laboratorio) y/o que curse con alteraciones radiológicas.
Lumbalgias	La Lumbalgia con hallazgos neurológicos
Endocrinológicas	Bocio

	Tiroiditis - Aguda - Crónica Dislipidemia Síndrome de Cushing Síndrome de Sheehan Galactorrea Acromegalia

Responsable del cumplimiento

- Directores de Áreas de Salud y Hospitales
- Jefes de Consulta Externa, Hospitalización y Emergencias
- Jefes de Pediatría y Neonatología
- Personal de medicina y enfermería de los Hospitales y Áreas de Salud

Responsable de verificar el cumplimiento

- Directores de Hospitales y Áreas de Salud
- Jefes de Consulta Externa, Hospitalización y Emergencias
- Jefes de Pediatría y Neonatología
- Dirección de Red de Servicios de Salud
- Programa de Normalización de la Atención del Niño y la Niña.

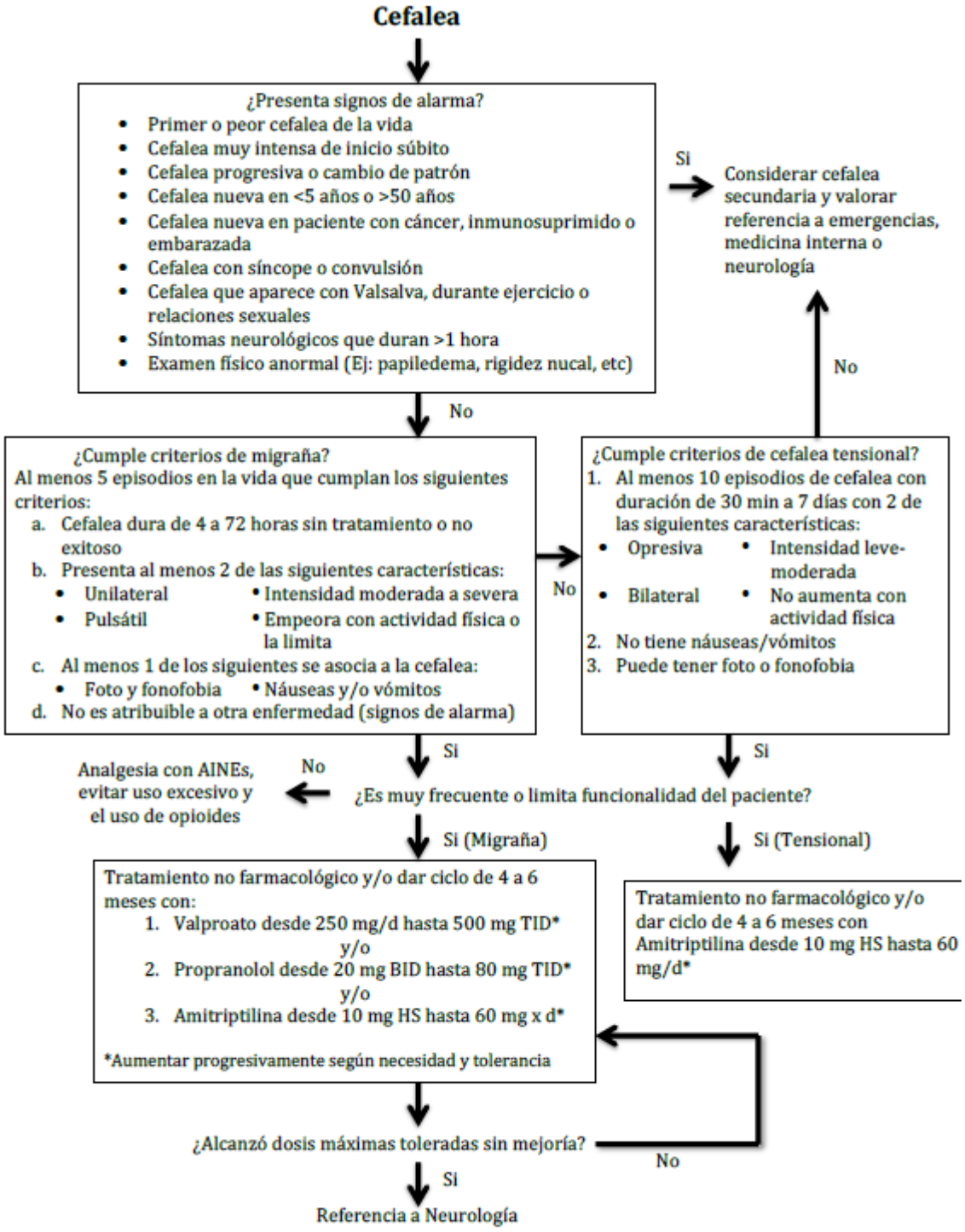
Monitoreo y evaluación

- Directores de Hospitales y Áreas de Salud
- Jefes de Servicios
- Dirección de Red de Servicios de Salud
- Programa de Normalización de la Atención del Niño y la Niña.

Contacto para consultas

- Dr.

Anexos


Cefalea
¿Presenta signos de alarma?
Primer o peor cefalea de la vida
Cefalea muy intensa de inicio súbito
Cefalea progresiva o cambio de patrón
Cefalea nueva en <5 años o >50 años
Cefalea nueva en paciente con cáncer, inmunosuprimido o embarazada
Cefalea con síncope o convulsión
Cefalea que aparece con Valsalva, durante ejercicio o relaciones sexuales
Síntomas neurológicos que duran >1 hora
Examen físico anormal (Ej: papiledema, rigidez nucal, etc)
Si
Considerar cefalea secundaria y valorar referencia a emergencias, medicina interna o neurología
No
¿Cumple criterios de migraña?
Al menos 5 episodios en la vida que cumplan los siguientes criterios:
a. Cefalea dura de 4 a 72 horas sin tratamiento o no exitoso
b. Presenta al menos 2 de las siguientes características:
Unilateral
Pulsátil
Intensidad moderada a severa
Empeora con actividad física o la limita
c. Al menos 1 de los siguientes se asocia a la cefalea:
Foto y fonofobia
Náuseas y/o vómitos
d. No es atribuible a otra enfermedad (signos de alarma)
No
¿Cumple criterios de cefalea tensional?
1. Al menos 10 episodios de cefalea con duración de 30 min a 7 días con 2 de las siguientes características:
Opresiva
Bilateral
Intensidad leve-moderada
No aumenta con actividad física
2. No tiene náuseas/vómitos
3. Puede tener foto o fonofobia
Si
Si
¿Es muy frecuente o limita funcionalidad del paciente?
No
Analgesia con AINEs, evitar uso excesivo y el uso de opioides
Si (Migraña)
Si (Tensional)
Tratamiento no farmacológico y/o dar ciclo de 4 a 6 meses con:
1. Valproato desde 250 mg/d hasta 500 mg TID*
y/o
2. Propranolol desde 20 mg BID hasta 80 mg TID*
y/o
3. Amitriptilina desde 10 mg HS hasta 60 mg x d*
*Aumentar progresivamente según necesidad y tolerancia
Tratamiento no farmacológico y/o dar ciclo de 4 a 6 meses con Amitriptilina desde 10 mg HS hasta 60 mg/d*
¿Alcanzó dosis máximas toleradas sin mejoría?
No
Si
Referencia a Neurología